麻醉（0~2题） ★☆☆

椎管内麻醉

阻滞顺序（2013）：交感神经→副交感神经→感觉神经→运动神经→本体感觉 / 深感觉
阻滞平面（2021）：T2 胸骨角、T4 乳头、T6 剑突、T8 肋弓、T10 脐、T12 耻骨联合上 2~3cm/ 腹股沟平面

麻醉平面调节：硬膜外阻滞 - 穿刺间隙；蛛网膜下腔阻滞 - 麻药剂量、患者体位
“硬膜外打哪最重要、腰麻打多少最重要”（2009）

骶管和鞍区麻醉可用于肛门、会阴部手术
“肛麻：躺着吃里脊、坐在马鞍上、扇我下马威、除开睾丸术”

	骶管麻醉	鞍区麻醉
本质	硬膜外麻醉（阻滞骶脊神经）	蛛网膜下腔麻醉（阻滞骶尾神经）
体位	侧卧、俯卧位	坐位
定位	骶管裂孔	L3-L5 椎体
主要并发症	全脊髓麻醉、局麻药毒性反应、尿潴留	马尾综合征（二便障碍）、头痛、尿潴留